

Ataque de Pánico

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es un ataque de pánico?

Un ataque de pánico es un episodio súbito de miedo intenso o malestar físico extremo que alcanza su pico en cuestión de minutos. Se caracteriza por síntomas físicos y cognitivos muy intensos que pueden llevar a la persona a creer que está en peligro de muerte, perdiendo el control o volviéndose loca.

El ataque de pánico es la activación del sistema de alarma del organismo (respuesta de lucha-huida) en ausencia de un peligro real o ante estímulos que no lo justifican. La respuesta fisiológica es real e intensa, aunque el peligro no lo sea.

Características centrales:

- Inicio súbito, con pico de intensidad en los primeros 10 minutos
- Duración habitual: entre 5 y 30 minutos
- Alta intensidad de los síntomas físicos
- Pensamientos catastrofistas durante el episodio
- Sensación de pérdida de control o peligro inminente

02. Síntomas

Síntomas físicos frecuentes:

- Palpitaciones o taquicardia
- Sensación de ahogo o falta de aire
- Opresión o dolor en el pecho
- Mareos, inestabilidad o sensación de desmayo
- Sudoración, temblores, escalofríos o sofocos
- Parestesias: entumecimiento u hormigueo en manos, pies o cara
- Náuseas o molestias abdominales
- Desrealización (sensación de irrealdad) o despersonalización (sentirse ajeno al propio cuerpo)

Síntomas cognitivos:

- "Me estoy muriendo" / "Estoy teniendo un infarto"
- "Me estoy volviendo loco/a" / "Estoy perdiendo el control"
- "No voy a poder salir de esto"

03. Diferencia entre ataque de pánico y ataque de ansiedad

Dimensión	Ataque de pánico · Ataque de ansiedad
Inicio	Súbito, sin señales previas claras · Gradual, con escalada de tensión previa
Intensidad	Muy alta, pico en minutos · Variable, generalmente menos abrupta
Síntomas físicos	Prominentes e intensos (palpitaciones, ahogo, mareos) · Presentes pero menos agudos
Cognición central	"Me estoy muriendo / perdiendo el control" · "No puedo con esto / algo malo va a pasar"
Duración	Breve (5-30 min) · Puede sostenerse por horas
Contexto	Puede ocurrir sin causa aparente (espontáneo) · Generalmente

Dimensión	Ataque de pánico · Ataque de ansiedad
	ligado a un estresor identificable
Diagnóstico relacionado	Trastorno de pánico si se repiten + ansiedad anticipatoria · Trastorno de ansiedad generalizada, fobias, estrés

04. El ciclo del pánico

El ataque de pánico se sostiene y repite a través de un ciclo bien identificado:

- Sensación corporal o pensamiento disparador (ej: taquicardia leve, mareo)
- Interpretación catastrófica de la sensación ("algo grave está pasando")
- Activación del sistema de alarma: los síntomas físicos aumentan
- La intensificación de síntomas confirma la percepción de peligro
- Escalada hasta el pico del episodio
- Después del episodio: ansiedad anticipatoria y conductas de evitación

Clave clínica: El miedo a tener otro ataque es el principal factor que mantiene el trastorno de pánico. La evitación de situaciones asociadas refuerza ese miedo.

05. Qué hacer durante un ataque de pánico

El objetivo durante el episodio no es eliminarlo de forma inmediata, sino reducir la escalada y tolerar las sensaciones:

- Reconocer: "Esto es un ataque de pánico. Es muy incómodo pero no es peligroso."
- No huir de la situación si es posible: el escape refuerza el ciclo
- Respiración diafragmática lenta: inhalar 4 seg · retener 2 · exhalar 6
- Anclar en el presente: nombrar 5 cosas visibles, 4 sonidos, 3 texturas
- Permitir que la ola pase: la ansiedad tiene un pico y luego desciende de forma natural
- Evitar hiperventilación: respiraciones lentas y profundas, no rápidas

06. Tratamiento

El trastorno de pánico responde muy bien al tratamiento cognitivo-conductual:

- Psicoeducación sobre el ciclo del pánico y la naturaleza de los síntomas
- Reestructuración cognitiva: cuestionamiento de las interpretaciones catastrofistas
- Exposición interoceptiva: exposición gradual a las sensaciones físicas temidas
- Exposición situacional: retorno progresivo a situaciones evitadas
- Técnicas de regulación fisiológica: respiración, relajación muscular
- Medicación: en algunos casos, como complemento al tratamiento psicológico